

Devoir N°4 : la dépression

I. Introduction :

La dépression est un trouble de l'humeur qui se manifeste par une tristesse persistante, une perte d'intérêt ou de plaisir pour les activités du quotidien, ainsi qu'un mal-être profond qui s'installe dans la durée. Elle est souvent confondue avec un simple « coup de blues », c'est-à-dire une baisse de moral passagère, liée à une fatigue, une contrariété ou une période difficile. Or, la dépression se distingue par son intensité, sa durée et son impact important sur la vie personnelle, sociale et professionnelle.

Afin de mieux comprendre ce trouble et d'apporter des réponses adaptées, il est nécessaire de l'analyser sous plusieurs aspects. Dans ce travail, nous aborderons la dépression selon trois dimensions complémentaires : émotionnelle, physique et physiologique, puis neuronale.

Sur le plan émotionnel, la dépression s'accompagne très souvent d'une tristesse profonde, de pleurs spontanés, d'une perte de plaisir et d'une angoisse difficile à apaiser. Ces manifestations entraînent un découragement progressif, une perte de motivation et une vision négative de soi et de l'avenir.

Sur le plan physique et physiologique, elle se traduit par une fatigue persistante, un ralentissement général, une diminution de l'énergie, ainsi que des troubles du sommeil et de l'appétit. Ces symptômes affectent directement le fonctionnement quotidien de la personne et peuvent conduire à un isolement social. Lorsqu'elle n'est pas prise en charge, la dépression peut durer des semaines, des mois, voire des années, et entraîner des conséquences graves, allant jusqu'aux pensées ou tentatives suicidaires.

Sur le plan neuronal, les avancées scientifiques ont permis d'identifier plusieurs zones du cerveau impliquées dans la dépression. Certaines régions, comme le cortex préfrontal médial, sont liées à la tristesse et à la dévalorisation de soi. D'autres, comme le cortex préfrontal dorsolatéral gauche, interviennent dans les fonctions cognitives et la mémoire. Le précunéus est associé à la rumination mentale, tandis que le cortex cingulaire ventral est sensible aux situations de rejet ou d'exclusion sociale.

Ces dysfonctionnements sont liés à un dérèglement de la transmission de l'information entre les neurones, impliquant notamment trois neurotransmetteurs essentiels : la sérotonine, qui régule l'humeur, le sommeil et l'appétit ; la dopamine,

liée à la motivation et au plaisir ; et la noradrénaline, qui intervient dans la gestion du stress et de la vigilance.

En résumé, la dépression est un trouble complexe qui touche à la fois le corps, les émotions et le fonctionnement mental. Toutefois, comme nous le verrons dans ce mémoire, il existe des approches complémentaires permettant d'accompagner la personne souffrante, notamment à travers les remèdes naturels et les enseignements de la médecine prophétique, qui proposent une vision globale de la santé intégrant le corps, le cœur et l'âme.

II. Description

2.1 Les symptômes

Les symptômes de la dépression peuvent varier d'une personne à une autre. Que l'on soit un homme, une femme, une personne âgée ou même un enfant, les manifestations ne seront pas toujours identiques.

Cependant, il existe des signes fréquents qui permettent de reconnaître un état dépressif. En général, pour parler d'un état dépressif, il faut retrouver plusieurs symptômes, présents presque tous les jours, et qui durent au moins deux semaines.

Le premier symptôme est souvent une tristesse profonde. Elle peut se manifester par des pleurs, une perte d'appétit, une perte de vitalité ou encore une sensation de vide. Dans les cas les plus sévères, cette tristesse peut conduire à une forme de léthargie, à un isolement social, et à un sentiment de solitude. On considère que cette tristesse devient inquiétante lorsqu'elle persiste dans le temps, sans amélioration.

Un autre symptôme très présent est l'abattement. Il s'agit d'un état psychologique qui entraîne un épuisement physique et un découragement moral. La personne a l'impression que ses efforts sont inutiles, elle se fatigue rapidement, et peut perdre confiance en elle. Cela s'accompagne parfois d'un ralentissement psychomoteur, avec une parole plus lente et une diminution générale de l'énergie.

La dépression entraîne aussi une modification de l'humeur. La tristesse s'intensifie, devient excessive, et prend des proportions qui ne sont plus normales. La personne peut paraître inconsolable et souffrir d'une absence totale d'espoir. Souvent, même les choses agréables ne procurent plus de plaisir. C'est ce qu'on appelle la perte d'intérêt, ou la perte de plaisir dans les activités quotidiennes.

On retrouve également une perte des relations sociales. La personne se renferme, évite les sorties, répond moins aux proches, et préfère rester seule. Cela accentue souvent la souffrance, car l'isolement renforce le mal-être.

Sur le plan physique, la dépression peut s'accompagner de troubles de l'alimentation, comme une perte d'appétit ou au contraire des crises de boulimie. Elle peut aussi provoquer des troubles du sommeil, comme l'insomnie ou l'hypersomnie. La fatigue devient alors permanente, et la personne se sent vidée, même après une nuit de sommeil.

Sur le plan mental, la dépression entraîne souvent des difficultés de concentration, des troubles de la mémoire, et une difficulté à prendre des décisions. La personne

peut aussi ressentir une forte dévalorisation, avec des pensées négatives sur elle-même, et une culpabilité excessive, parfois injustifiée.

Enfin, dans les formes les plus graves, il peut y avoir des pensées noires, des idées liées à la mort, ou même des pensées suicidaires. Ce symptôme doit toujours être pris au sérieux, car il peut conduire à des passages à l'acte si la situation n'est pas prise en charge.

Variations selon certaines situations :

Chez les personnes âgées, la dépression est parfois plus difficile à détecter, car elle se manifeste différemment. On retrouve souvent une baisse de concentration, un ralentissement général, une anxiété, des troubles cognitifs, et parfois même des symptômes physiques comme une constipation chronique.

Dans le cas de la dépression post-partum, on observe une tristesse persistante, une humeur dépressive, une incapacité à apprécier les choses, une fatigue intense, une perte d'énergie et des troubles du sommeil. Si ces symptômes durent au-delà de quinze jours, cela nécessite une prise en charge.

Enfin, chez les enfants, la dépression peut se manifester par de l'anxiété, du stress, un refus d'aller à l'école, des maux de ventre, des maux de tête, des pleurs fréquents, des cris, ainsi que des troubles du sommeil.

2.2 Les causes et conséquences

La dépression se caractérise par des troubles complexes, que ce soit sur l'aspect de la santé physique, mentale, émotionnelle, ou encore sur la vie sociale et professionnelle. Ces troubles peuvent être la somme de causes d'ordre génétique, biologique, environnemental et psychologique.

De ce fait, nous comprenons bien qu'il est difficile d'en déterminer une cause unique. Cependant, nous commencerons par expliquer les facteurs les plus courants associés à son développement, en les catégorisant, puis nous en présenterons les conséquences dans un second temps.

A. Les causes de la dépression

A1. Sur le plan de la santé physique,

On peut identifier plusieurs causes pouvant favoriser ou aggraver la dépression, notamment certaines maladies chroniques comme les maladies cardiaques. En effet, les maladies cardiaques mettent le corps dans un stress permanent, avec une inflammation chronique, un dérèglement des hormones du stress, une fatigue importante, un essoufflement et parfois une baisse de l'oxygénation. Ces éléments impactent directement le cerveau, notamment le sommeil, l'énergie, la motivation et l'humeur.

On retrouve ensuite le diabète, qui peut également favoriser ou aggraver un état dépressif. Le diabète se caractérise par un pancréas qui ne produit pas suffisamment d'insuline, ce qui entraîne une mauvaise régulation de la glycémie. En ce sens, les variations de glycémie, qu'il s'agisse d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie, influencent directement l'humeur, l'énergie, la concentration et le sommeil. Cela peut provoquer davantage d'irritabilité, de fatigue et une baisse de motivation. De plus, le diabète favorise l'inflammation chronique et la résistance à l'insuline, deux facteurs associés à un risque plus élevé de symptômes dépressifs.

On peut aussi citer l'obésité. D'après l'OMS, on considère une personne obèse lorsque son IMC est supérieur à 30. Les risques liés à l'obésité sont nombreux, et parmi eux, on retrouve une augmentation du risque d'hypertension artérielle, d'athérosclérose (notamment à cause de l'inflammation des artères), de dyslipidémie, de maladies du foie comme la stéatohépatite non alcoolique, ainsi que de maladie rénale chronique. Ainsi, l'obésité peut aggraver une dépression car elle s'accompagne souvent d'un déséquilibre biologique, comme l'inflammation chronique, la résistance à l'insuline et certains dérèglements hormonaux. Ces facteurs influencent directement le cerveau, le sommeil et l'énergie, ce qui augmente la fatigue, la baisse de motivation et l'humeur dépressive. Elle peut aussi limiter l'activité physique et provoquer un essoufflement, des douleurs articulaires ou une gêne corporelle, ce qui réduit les sorties et favorise l'isolement. Sur le plan

psychologique, la honte, la mauvaise image de soi, la pression sociale, les remarques ou le jugement peuvent renforcer les pensées négatives et l'anxiété.

Enfin, les troubles alimentaires, comme le grignotage émotionnel ou les compulsions, entretiennent un cercle vicieux : mal-être, alimentation, culpabilité, puis aggravation du mal-être.

On retrouve également les troubles du sommeil, comme l'insomnie ou l'hypersomnie. L'insomnie se définit par une difficulté à s'endormir ou à rester endormi, un réveil précoce, ou encore une impression de sommeil non réparateur. Les troubles du sommeil peuvent aggraver une dépression car le manque de sommeil dérègle directement le cerveau : il augmente le cortisol (hormone du stress), réduit la capacité à gérer les émotions, diminue la motivation et accentue la fatigue, la tristesse et l'irritabilité. Ils perturbent également les neurotransmetteurs liés à l'humeur, notamment la sérotonine et la dopamine, et affaiblissent la concentration, ce qui donne l'impression de "ne plus être soi-même". Enfin, les nuits difficiles favorisent les ruminations, l'anxiété et le sentiment d'impuissance, créant un cercle vicieux : plus on dort mal, plus le moral chute, et plus la dépression rend le sommeil difficile.

On peut aussi citer les douleurs chroniques. Une douleur chronique se caractérise par une douleur qui persiste ou se reproduit pendant plus de trois mois. L'objectif de sa prise en charge est rarement la disparition totale de la douleur, mais plutôt la réduction du handicap qu'elle provoque et l'amélioration de la qualité de vie. Les douleurs chroniques peuvent favoriser ou aggraver une dépression car elles épuisent le corps et le mental en permanence. Elles augmentent le stress, l'inflammation et perturbent le sommeil, ce qui diminue l'énergie et la capacité à gérer les émotions. Elles réduisent aussi l'activité physique, les sorties et les plaisirs du quotidien, ce qui favorise l'isolement et la perte de motivation. À force, la douleur crée un sentiment d'impuissance, nourrit les pensées négatives et peut entraîner irritabilité, anxiété et baisse d'estime de soi. Ainsi, douleur et dépression se renforcent souvent mutuellement dans un cercle vicieux.

Enfin, il existe également des problèmes gastriques, qui se caractérisent par des troubles digestifs, des douleurs et un inconfort chronique centré sur la région de l'estomac (épigastre). Les problèmes gastriques peuvent aggraver une dépression car l'intestin et le cerveau sont étroitement liés, notamment par ce que l'on appelle l'axe intestin-cerveau. Une digestion perturbée, comme le reflux, la gastrite, les ballonnements, les douleurs, la diarrhée ou la constipation, augmente le stress, l'inflammation et dérègle le microbiote, ce qui peut influencer directement l'humeur, l'anxiété et la motivation. De plus, l'inconfort quotidien fatigue, gêne le sommeil, réduit l'appétit ou au contraire provoque des compulsions alimentaires, et pousse parfois la personne à s'isoler par peur des symptômes. À long terme, cette charge physique et mentale entretient le cercle vicieux : stress, troubles digestifs, baisse du moral, puis aggravation du stress.

A.2 Sur le plan hormonal

Les facteurs hormonaux peuvent également déclencher ou favoriser une dépression. Cela peut concerner les changements hormonaux liés à la grossesse, la période post-partum, la ménopause, ou encore certaines conditions médicales comme les troubles de la thyroïde.

A.3 Sur le plan génétique et biologique

La dépression peut être plus fréquente chez les personnes ayant des antécédents familiaux, suggérant un lien génétique. De plus, les déséquilibres dans les neurotransmetteurs du cerveau, tels que la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline, sont souvent impliqués dans la dépression.

A.4 Sur le plan psychologique et environnemental

Les événements de vie stressants peuvent aussi déclencher une dépression, comme la perte d'un être cher, un divorce, des problèmes financiers ou d'autres stress majeurs, surtout chez les personnes ayant une prédisposition.

Les traumatismes, notamment pendant l'enfance, ainsi que le stress chronique, augmentent également le risque de développer une dépression.

Enfin, des traits de personnalité comme le pessimisme ou une faible estime de soi, ainsi que des troubles psychologiques comme l'anxiété ou le trouble de stress post-traumatique, peuvent être des facteurs aggravants.

A.5 Sur le plan social et comportemental

Le manque de soutien social et l'isolement peuvent être à la fois une cause et un facteur aggravant de la dépression.

De plus, l'abus de substances (alcool, drogues), ainsi que certains médicaments, peuvent contribuer au développement ou à l'aggravation de la dépression.

B. Les conséquences de la dépression

B.1 Sur le plan de la santé physique

La dépression peut entraîner ou aggraver certaines conditions de santé chroniques telles que les maladies cardiaques, le diabète, l'obésité, les troubles du sommeil, les douleurs chroniques et les troubles gastro-intestinaux. Elle peut également provoquer une fatigue importante, une baisse d'énergie et une diminution de la vitalité au quotidien.

B.2 Sur le plan de la santé mentale et émotionnelle,

La dépression non traitée peut entraîner une baisse d'énergie et une diminution de la qualité de vie, marquée par un manque d'intérêt pour les activités habituelles (sortie en famille, activité ludique etc...). De plus, elle peut aggraver les troubles comme la schizophrénie, et affecter les fonctions cognitives entraînant des difficultés de concentration, de mémoire, de prise de décision et pouvant également renforcer les troubles de la personnalité, ou des Idées suicidaires.

B.3 Sur le plan de la vie Sociale et Professionnelle,

La dépression peut aussi avoir un impact négatif sur les relations familiales, amicales et les collègues de travail, en raison de l'irritabilité, du retrait social et de la difficulté à communiquer. En effet, la situation psychologique devient tellement incontrôlable qu'elle engendre un repli identitaire conduisant à un isolement social et de surcroît impactant négativement les relations personnelles mais aussi professionnels, pouvant impliquer une perte d'emploi.

B.4 Sur le plan comportemental,

Les personnes souffrant de dépression peuvent être plus susceptibles de s'engager dans des comportements à risque pouvant devenir des addictions tels que l'abus de substances, le tabagisme, et l'alcoolisme.

C. Ma situation personnelle

Afin de mieux apprendre à me connaître, dans l'intention de développer mon activité de coaching en ligne pour la communauté, j'ai effectué un travail sur moi. Dans celui-ci, j'ai identifié plusieurs situations traumatisantes, et la plupart d'entre elles remontent à l'enfance, plus précisément entre 10 et 15 ans.

À cette période, je ne connaissais pas encore l'islam, mais j'étais, par la Grâce d'Allah, en recherche spirituelle. Je me souviens que j'étais souvent peu souriant, enfermé sur moi-même, et régulièrement en pleine réflexion sur mon rôle dans ce monde. Le seul point de référence que j'utilisais pour évaluer ma valeur était le système scolaire. J'ai grandi dans une famille où l'on me répétait souvent qu'il fallait bien travailler à l'école pour avoir un bon travail. J'ai donc associé le travail à la réussite, et l'école comme étant le premier socle pour y parvenir.

Je travaillais plus que mes camarades de classe. Je sacrifiais mes week-ends pour les devoirs maison et les révisions, plutôt que d'aller à des anniversaires ou de sortir entre amis, car mon seul objectif était de rendre mes parents fiers. Pourtant, j'avais souvent les mêmes résultats que des camarades qui travaillaient moins que moi. Mon père disait parfois en s'adressant à mes frères et moi : « La seule chose qu'on vous demande, c'est de bien travailler à l'école, et même ça, vous n'y arrivez pas. » J'y ai donc vu de la déception, malgré mes efforts.

Arrivé en seconde, je me souviens que rien n'allait dans ma vie. J'avais changé d'établissement scolaire, il fallait que je me refasse des amis, que je retrouve des repères dans ce nouvel environnement, et sur le plan scolaire j'avais décroché. Pour moi, c'était une période de chaos. J'avais des pensées négatives comme : « Pourquoi je n'y arrive pas ? Je suis nul. » Car j'évaluais ma valeur aux notes attribuées par le système scolaire.

Les conséquences de cette période ont été marquées par une faible estime de moi, un repli sur moi-même, un stress constant de ne pas me sentir à la hauteur de ce qu'attendaient mes parents, et des pensées pessimistes du type : « Pourquoi faire des efforts alors qu'on finira tous par mourir ? » Avec le recul, je comprends que cette période a contribué à installer en moi un mal-être profond, et j'ai même eu des idées suicidaires.

III. Les remèdes naturels

La dépression est un trouble complexe. Elle ne se limite pas à une tristesse passagère, mais peut toucher la personne dans toutes les dimensions de sa vie : motivation, sommeil, énergie, pensée, relations, alimentation, et même la perception de soi. Dans une approche naturelle, l'objectif n'est pas de remplacer systématiquement un traitement médical, mais de soutenir la personne, de renforcer ses capacités d'adaptation, et de diminuer l'intensité des symptômes.

Les remèdes naturels ont une place importante, car ils agissent souvent sur plusieurs axes en même temps : le stress, le sommeil, la fatigue mentale, les carences, les déséquilibres hormonaux, ou encore le microbiote intestinal. On peut résumer l'approche en quatre catégories principales. On cherche généralement à agir avec un antidépresseur naturel, un anxiolytique, un sédatif, et un adaptogène. Cette logique permet d'accompagner la personne de manière globale, tout en respectant son état, son rythme, et la gravité de sa situation.

3.1 La rhodiola : antidépresseur, anxiolytique et adaptogène



La rhodiola est une plante très utilisée dans les états de fatigue nerveuse, de stress chronique, et de dépression légère à modérée. Elle est connue pour son effet adaptogène, c'est-à-dire sa capacité à aider le corps à mieux s'adapter au stress. Elle est aussi souvent décrite comme un antidépresseur naturel, car elle soutient l'énergie mentale, la motivation, et la stabilité émotionnelle.

La rhodiola est parfois surnommée le ginseng de la toundra. Son odeur rappelle légèrement la rose. Dans l'esprit, on peut rapprocher son effet stimulant et réchauffant de certaines plantes évoquées dans la tradition, comme le gingembre, même si ce n'est pas la même espèce.

Les trois composants souvent cités dans la rhodiola sont la rosavine, le salidroside et la rosine. La rosavine est associée à un effet psychostimulant. Le salidroside est reconnu pour ses propriétés adaptogènes et neuroprotectrices. La rosine contribue à l'effet global de la plante.

Sur le plan des effets, la rhodiola peut réduire le stress, diminuer les symptômes du burn-out, améliorer les fonctions cérébrales, et renforcer les performances professionnelles et sportives. Elle peut aussi agir sur le système cardiovasculaire en soutenant la régulation du cœur et l'oxygénation du sang. Certaines recherches lui attribuent également un effet antioxydant et une action sur la modulation de la sérotonine.

Dans la pratique, la rhodiola est souvent conseillée le matin, et il est recommandé de l'associer au safran, car cette combinaison agit à la fois sur l'humeur, la motivation, et la résistance au stress.

3.2 La mélisse : apaisement de l'anxiété et soutien du sommeil



La mélisse est une plante très intéressante lorsque la dépression est accompagnée d'angoisse, de tension intérieure, ou de troubles digestifs. Son odeur citronnée est facilement reconnaissable, et on utilise principalement les tiges et les fleurs.

Elle est connue pour ses propriétés anxiolytiques et sédatives. Elle peut aider à réduire le stress, calmer les palpitations liées à l'anxiété, et favoriser un sommeil plus profond. Elle est aussi utilisée dans certains troubles gastriques, car l'anxiété et l'estomac sont souvent liés.

La mélisse est donc particulièrement utile chez les personnes qui vivent une dépression avec agitation intérieure, ruminations, ou instabilité émotionnelle.

3.3 Le tilleul : un sédatif naturel simple mais efficace



Le tilleul est un remède traditionnel très répandu. Son efficacité est particulièrement visible lorsque la dépression est accompagnée d'insomnie, de nervosité, ou de pensées envahissantes. Il agit comme un calmant du système nerveux.

Son intérêt est qu'il est accessible, doux, et souvent bien toléré. Il peut être utilisé en tisane, notamment le soir, afin de favoriser la détente et préparer le sommeil.

3.4 Le ginseng de Corée : soutien de l'énergie mentale et physique



Le ginseng de Corée est un adaptogène puissant. Il est particulièrement utile lorsque la dépression s'accompagne d'une fatigue intense, d'une perte d'énergie, et d'une diminution des fonctions cognitives. Il est aussi connu pour son effet tonifiant et stimulant.

Les ginsénosides sont les principaux composés actifs responsables de ses effets. Le ginseng contient également de nombreux minéraux et éléments actifs.

Sur le plan clinique, il est souvent utilisé pour réduire la fatigue, améliorer la concentration, soutenir la mémoire, et renforcer la résistance au stress. Il peut aussi améliorer la circulation sanguine, ce qui contribue à un meilleur apport en oxygène et en nutriments au cerveau.

3.5 Le henné : amélioration de la circulation et détente



Le henné est parfois utilisé en médecine naturelle sous certaines formes. Il peut contribuer à améliorer la circulation sanguine, à détendre le corps, et à soutenir l'apport en oxygène au niveau cérébral. Son intérêt dans la dépression est donc surtout indirect, car il soutient le corps, notamment lorsque la personne est épuisée, tendue, ou fatiguée.

3.6 Le ginkgo biloba : soutien de l'irrigation cérébrale



Le ginkgo biloba est connu pour son action sur la circulation sanguine, en particulier au niveau cérébral. Il est utilisé pour améliorer l'irrigation du cerveau et soutenir les fonctions cognitives. Il possède également des propriétés antioxydantes.

Cependant, il a aussi un effet anticoagulant. Cela implique une prudence importante, car il peut être contre-indiqué chez les personnes qui prennent déjà des anticoagulants ou qui ont des troubles de coagulation.

3.7 Le millepertuis : un antidépresseur naturel puissant



Le millepertuis est l'un des remèdes naturels les plus connus contre la dépression légère à modérée. Il est particulièrement utile lorsque la personne souffre d'une tristesse persistante, d'une perte d'intérêt, d'une baisse de motivation, et d'une diminution de l'énergie.

La molécule la plus citée est l'hyperforine. Elle est connue pour agir sur les neurotransmetteurs liés à l'humeur, notamment la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline.

Néanmoins, le millepertuis est aussi l'un des remèdes naturels qui présentent le plus d'interactions médicamenteuses. Il ne doit pas être associé à un traitement chimique antidépresseur, car cela peut entraîner des effets indésirables importants. Cette plante doit donc être utilisée avec prudence et encadrement.

3.8 Le griffonia : soutien de la sérotonine



Le griffonia est riche en 5-HTP, qui est un précurseur direct de la sérotonine. Son intérêt est particulièrement visible dans les dépressions associées à des troubles du sommeil, à une anxiété marquée, ou à une instabilité émotionnelle.

En soutenant la production de sérotonine, il peut contribuer à améliorer l'humeur, faciliter l'endormissement, et réduire les pensées anxieuses. Il peut être associé à certaines plantes calmantes, comme la valériane, l'aubépine ou la passiflore, selon le profil de la personne.

IV. Dépression liée aux troubles hormonaux : un cas particulier

Certaines formes de dépression sont fortement influencées par les hormones. Cela peut être observé pendant la grossesse, après l'accouchement, pendant l'allaitement, lors d'une hypothyroïdie, pendant le cycle menstruel, ou encore à la ménopause.

Dans ces situations, il est important de comprendre que la personne ne vit pas uniquement une souffrance psychologique. Il peut exister un déséquilibre physiologique réel. Une approche naturelle pertinente doit donc inclure un travail sur la régulation hormonale.

Parmi les plantes utilisées dans ce contexte, on retrouve la marjolaine, la sauge, et le gattilier.

4.1 Le gattilier : régulation du syndrome prémenstruel et de l'humeur



Le gattilier est une plante souvent utilisée dans les troubles liés au syndrome prémenstruel. Il est reconnu pour son action sur certains déséquilibres hormonaux et sur les symptômes émotionnels qui peuvent accompagner ces périodes.

Ses principes actifs incluent notamment des iridoïdes et des phytoprogestérones. Il peut contribuer à diminuer l'irritabilité, les variations d'humeur, et certains symptômes associés aux cycles irréguliers ou aux troubles hormonaux comme le SOPK.

Une particularité importante du gattilier est son influence sur les mécanismes dopaminergiques, ce qui peut expliquer une partie de son effet sur l'équilibre émotionnel.

4.2 Le safran : un antidépresseur naturel reconnu

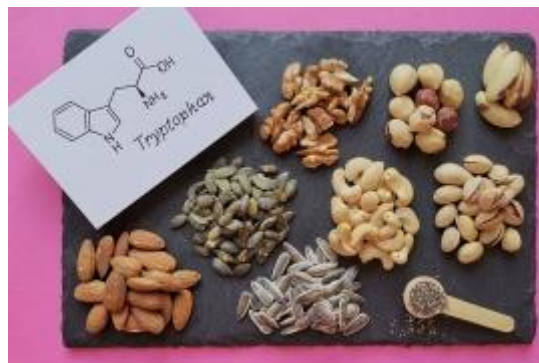


Le safran est un remède naturel très intéressant dans les troubles de l'humeur. Il agit de manière douce mais réelle. Il est souvent utilisé dans la dépression légère à modérée, mais aussi dans certains états d'anxiété.

Le safranal est l'un des composants actifs principaux. Il contribue à l'effet antidépresseur, notamment par une action sur la sérotonine.

L'intérêt du safran est qu'il est souvent mieux toléré que certains stimulants. Il peut aussi être associé à la rhodiola le matin, afin de renforcer l'effet global sur l'humeur et la motivation.

4.3 Le tryptophane : précurseur de la sérotonine et de la mélatonine



Le tryptophane est un acide aminé essentiel. Le corps ne pouvant pas le produire, il doit être apporté par l'alimentation ou par complémentation.

Il joue un rôle important, car il est un précurseur de la sérotonine, et il participe également à la synthèse de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil.

Le tryptophane est donc particulièrement utile dans les cas de dépression saisonnière, de troubles du sommeil, ou de fatigue émotionnelle. Il peut aussi soutenir la régulation de l'appétit, car la sérotonine influence directement ce domaine.

V. Les compléments alimentaires essentiels

5.1 Le magnésium



Le magnésium est l'un des compléments les plus importants en cas de stress chronique, d'anxiété, et de dépression. Une carence en magnésium est fréquente, car le stress augmente la consommation de ce minéral.

Le magnésium soutient la relaxation musculaire, la transmission nerveuse, et la stabilité émotionnelle. Il contribue aussi à améliorer la qualité du sommeil.

On le retrouve dans plusieurs aliments, notamment les graines, le riz complet, les haricots, le chocolat noir et les épinards.

5.2 Les vitamines B



Les vitamines B jouent un rôle central dans le fonctionnement du système nerveux. Elles participent à la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine.

Une carence peut provoquer une fatigue importante, une baisse d'énergie, et une fragilité émotionnelle. Les complexes de vitamines B sont donc souvent conseillés dans les périodes de dépression, notamment lorsqu'il existe une fatigue mentale ou une baisse de motivation.

5.3 La théanine végétale



La théanine est un acide aminé présent principalement dans le thé. Elle est connue pour son effet relaxant sans provoquer de somnolence.

Elle peut aider à réduire la tension mentale, améliorer la concentration, et soutenir l'humeur. Elle est aussi associée à une augmentation de certains neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine.

VI. Les huiles essentielles dans la dépression

Les huiles essentielles peuvent avoir une action rapide sur le système nerveux, notamment grâce au lien direct entre l'odorat et le cerveau limbique, qui est le centre des émotions.

La camomille romaine est connue pour ses effets sédatifs, calmants et relaxants. Elle est utile en cas d'angoisse, d'anxiété, et pour favoriser un sommeil profond. Elle peut être utilisée en massage au niveau des tempes et du plexus solaire avant le coucher.

La fleur d'oranger est reconnue pour son effet sur le sommeil et l'humeur. Elle peut être utilisée en diffusion ou dans un bain.

La rose de Damas possède une action apaisante et antidépressive. Elle est parfois utile en cas de migraines liées au stress. Ses composants actifs principaux sont le citronellol et le géraniol.

La lavande fine est l'une des huiles les plus utilisées pour l'anxiété, l'irritabilité, l'insomnie et les troubles nerveux. Elle peut être utilisée en diffusion ou en massage.

VII. La gemmothérapie : l'action des bourgeons

La gemmothérapie repose sur l'utilisation des bourgeons et des jeunes pousses végétales. Ces éléments sont riches en principes actifs, car ils concentrent l'énergie de croissance de la plante.

Le bourgeon de figuier est souvent conseillé en cas d'angoisse, de stress, et de désordres nerveux. Il est aussi connu pour son action sur certains déséquilibres hormonaux, ce qui le rend intéressant dans les dépressions existentielles.

Le bourgeon de tilleul est utile dans les états de stress, de dépression, et de troubles du sommeil. Il apaise le système nerveux et favorise un sommeil réparateur.

L'apithérapie : miel et produits de la ruche



Le miel possède des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Il contribue aussi à un meilleur bien-être général, notamment par son apport énergétique et son effet apaisant.

Le miel de tilleul est particulièrement intéressant dans les troubles anxieux et la dépression. Il peut aider à calmer le stress, favoriser le sommeil, et réduire certains symptômes physiques associés, comme les brûlures d'estomac ou les migraines.

Le pain d'abeille est le résultat de la fermentation du pollen. Il est riche en nutriments, en vitamines, en minéraux, et notamment en tryptophane. Il peut soutenir l'énergie, la digestion, et l'humeur. Une cure classique dure environ six semaines.

Le venin d'abeille est parfois utilisé en médecine naturelle. Il peut être administré sous plusieurs formes, mais il doit être encadré, car le risque allergique existe réellement. Un test préalable est indispensable.

Conclusion (de la partie) : l'intérêt des remèdes naturels

Les remèdes naturels peuvent être un soutien très efficace dans la dépression, surtout lorsqu'ils sont adaptés au profil de la personne. Leur force est d'agir sur plusieurs dimensions en même temps : le sommeil, le stress, la fatigue, l'humeur, et parfois les hormones.

Cependant, la prudence est essentielle. Certaines plantes, comme le millepertuis, peuvent interagir fortement avec des médicaments. De plus, dans les cas sévères, la médecine naturelle ne doit jamais être utilisée comme unique solution. Elle doit s'inscrire dans une prise en charge globale, équilibrée, et parfois médicale.

Le rôle du conseiller en médecine prophétique et naturelle est donc d'être sage, à l'écoute, et de comprendre que la souffrance psychologique peut avoir plusieurs causes. Il doit soutenir la personne, l'aider à retrouver un cadre, et lui rappeler que la guérison se construit par étapes, avec patience, cohérence, et accompagnement.

VIII. La dépression dans le Coran et la Sounna

La dépression, comme l'angoisse, fait partie des épreuves les plus lourdes que peut traverser un être humain. Elle touche la personne dans son cœur, son esprit, son corps et parfois même dans sa foi. Elle peut donner l'impression que tout devient vide, que la motivation disparaît, que les pensées se noircissent, et que l'on n'arrive plus à se projeter.

Dans l'islam, il est important de comprendre une chose essentielle. Le fait d'être déprimé ne signifie pas forcément que l'on est faible, ni que l'on manque de foi. Cela peut être une épreuve, comme une maladie physique. Le croyant peut tomber, être épuisé, pleurer, perdre son énergie, et malgré cela être aimé d'Allah. Car Allah ne juge pas uniquement l'état dans lequel on se trouve, mais aussi l'effort intérieur, la patience, et la sincérité.

Le Coran et la Sounna ne nient pas la souffrance psychologique. Au contraire, ils la reconnaissent et donnent des moyens concrets pour la traverser. L'approche prophétique est globale. Elle s'occupe du cœur, de la relation avec Allah, du comportement, de l'hygiène de vie, des paroles, de l'entourage, et même de l'alimentation.

Les remèdes prophétiques

Les remèdes prophétiques ne sont pas uniquement des plantes ou des aliments. Ils incluent aussi des actes spirituels, des invocations, une manière de penser, une manière de vivre, et une manière de faire face à l'épreuve. On peut donc distinguer plusieurs catégories de remèdes prophétiques contre la dépression : le Coran, la prière, l'invocation, la patience, la gratitude, l'espoir, le soutien social, l'hygiène de vie et l'alimentation.

1) Le Coran : une guérison pour le cœur

Allah nous apprend clairement que le Coran est une guérison. Il ne s'agit pas seulement d'une guérison intellectuelle, mais d'une guérison profonde qui touche le cœur et l'âme.

Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset :

“Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants.”

(Sourate Younous, verset 57)

Ce verset est très fort, car il montre que le Coran soigne ce qui se passe à l'intérieur. Et dans une dépression, ce qui souffre le plus, ce n'est pas seulement le corps, c'est surtout l'intérieur : la vision de soi, la vision du monde, l'espoir, le sens, la confiance.

Mais pour que le Coran fasse effet, il faut une condition essentielle : être présent avec son cœur. Pas forcément en récitant beaucoup, mais en récitant avec sincérité. Allah dit, dans le sens du verset :

“Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur ou prête l’oreille en étant présent.”
(Sourate Qâf, verset 37)

Cela veut dire que le Coran agit vraiment lorsque la personne est dans un état de réception. Même si la dépression fatigue et empêche parfois la concentration, le simple fait de se poser et d’écouter avec attention est déjà une forme de soin.

Dans la dépression, le Coran peut agir sur plusieurs choses. Il peut apaiser les ruminations, calmer la peur de l’avenir, redonner du sens, et surtout rappeler au croyant qu’il n’est pas seul.

2) La prière : une thérapie spirituelle et émotionnelle

La prière est l’un des remèdes prophétiques les plus puissants. Le Prophète ﷺ ne voyait pas la prière comme une simple obligation. Il la voyait comme un refuge. Lorsqu’il était touché par une difficulté, il se tournait vers la prière. Cela nous montre que la prière n’est pas uniquement un acte rituel, mais un acte thérapeutique. Allah dit dans le sens du verset :

“Et cherchez secours dans la patience et la prière.”
(Sourate Al-Baqarah, verset 45)

La prière aide dans la dépression car elle recentre. Elle remet Allah au centre. Elle coupe le flot de pensées. Elle redonne une structure. Et surtout, elle fait passer le croyant de l’état de victime de ses émotions à l’état de serviteur qui se tient debout devant son Seigneur.

Même lorsque la personne n’a plus envie à cause de sa dépression, le fait de se lever et de prier est déjà une victoire.

3) L'invocation : une arme du croyant contre l'écrasement intérieur

Dans la dépression, la personne a souvent le sentiment d'être enfermée dans sa souffrance. L'invocation permet de sortir de cet enfermement.

L'invocation est un moment où la personne parle à Allah directement. Elle exprime ce qu'elle n'arrive pas à dire aux autres. Elle peut pleurer, demander, se plaindre à Allah, comme l'ont fait les prophètes.

Et cela est important : se plaindre à Allah n'est pas une faiblesse. C'est un signe de foi. Une invocation simple, souvent utilisée dans les épreuves, est :

“Ô Allah, rien n'est facile sauf ce que Tu rends facile. Et Tu rends facile la tristesse si Tu le veux.”

Cette invocation a une force psychologique énorme. Elle rappelle que même la tristesse peut être transformée. Que la difficulté n'est pas un mur définitif. Que la souffrance n'est pas éternelle. On retrouve aussi cette parole :

“Allah me suffit, il n'y a de divinité que Lui. En Lui je place ma confiance, et Il est le Seigneur du Trône immense.”

Cette invocation renforce le cœur car elle remet le croyant dans la confiance. Elle lui rappelle qu'il n'a pas besoin de porter le monde sur ses épaules. Il a besoin de s'en remettre à Celui qui contrôle tout.

4) Comprendre la réalité de la vie d'ici-bas

Un élément central dans le traitement prophétique de la dépression est la compréhension du sens de la vie. Beaucoup de dépressions modernes sont liées à une perte de sens. La personne ne comprend plus pourquoi elle souffre, pourquoi elle lutte, pourquoi elle vit.

L'islam remet une vérité fondamentale : ce bas monde n'est pas un paradis. C'est un lieu d'épreuve. Et l'épreuve ne signifie pas qu'Allah nous déteste. Elle signifie que la vie est faite pour tester, purifier, élever, et forger. Allah dit dans le sens du verset :

“Pensez-vous que vous entrerez au Paradis sans que ne vous atteigne ce qui a atteint ceux qui vous ont précédés ?”

(Sourate Al-Baqarah, verset 214)

Cela permet au croyant de comprendre que la souffrance n'est pas une anomalie. Elle fait partie du chemin. Et quand on comprend cela, la douleur devient plus supportable.

5) La patience : tenir, même quand on ne voit pas la fin

La patience, dans l'islam, n'est pas une passivité. Ce n'est pas "subir". La patience, c'est tenir. C'est rester debout intérieurement, même quand le cœur est lourd. La patience est liée à la connaissance d'Allah. Plus une personne connaît Allah, plus elle comprend que l'épreuve n'est pas inutile. Allah dit dans le sens du verset :

"Certes, avec la difficulté vient la facilité."

(Sourate Ash-Sharh, verset 5)

Ce verset est souvent cité, mais dans une dépression, il devient vital. Il rappelle une chose essentielle : la difficulté ne dure pas éternellement. Même si la personne ne voit pas encore la sortie, elle existe.

6) La gratitude : se reconstruire en se reconnectant aux bienfaits

Dans une dépression, la personne voit tout en noir. Même les bienfaits deviennent invisibles. L'islam nous apprend à revenir à la gratitude, non pas pour nier la souffrance, mais pour empêcher le cœur de mourir. Allah dit dans le sens du verset :

"Si vous êtes reconnaissants, J'augmenterai pour vous."

(Sourate Ibrâhîm, verset 7)

La gratitude est un remède, car elle rééduque le cerveau et le cœur. Elle oblige la personne à chercher la lumière, même quand l'obscurité est forte.

Parfois, la gratitude commence petit. Le fait d'avoir un lit. Le fait d'avoir de l'eau. Le fait d'être en vie. Le fait d'avoir encore une capacité de se tourner vers Allah.

7) Le soutien : ne pas rester seul

L'islam insiste énormément sur l'importance de l'entraide. La dépression pousse à l'isolement, mais l'isolement aggrave la dépression. Allah dit dans le sens du verset :

"Et entraidez-vous dans le bien et la piété."

(Sourate Al-Ma'idah, verset 2)

Le Prophète ﷺ encourageait la fraternité, la visite des malades, l'écoute, et le fait de prendre soin des autres. Cela nous montre que le croyant ne doit pas affronter seul. Il doit chercher des personnes de confiance, des proches, une famille, des amis, ou même un thérapeute si nécessaire. Et il est important de dire une chose clairement : se faire aider n'est pas un manque de foi. C'est une sunnah dans le sens où l'islam encourage l'utilisation des causes.

8) L'alimentation et la médecine prophétique

La médecine prophétique inclut aussi l'alimentation. On retrouve dans le Coran un verset très symbolique, lorsqu'Allah parle à Maryam, dans le sens :

“Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc, bois, et que ton œil se réjouisse.”

(Sourate Maryam, versets 24-25)

Ce passage est extrêmement profond. Maryam était dans un état de douleur, de solitude, et d'épreuve. Et Allah lui donne un remède très concret : manger, boire, et se calmer. Cela montre que la nourriture, l'hydratation et l'apaisement font partie de la guérison.

Les dattes, dans la tradition prophétique, ont une place particulière. Elles sont riches en énergie, en nutriments, et elles soutiennent le corps et le mental. Elles sont aussi liées à des hadiths connus, notamment sur les dattes Ajwa. On retrouve aussi la talbina, recommandée dans les états de tristesse.

Aïcha (qu'Allah l'agrée) rapportait que le Prophète ﷺ disait que la talbina réconforte le malade et fait partir une partie du chagrin. Ce point est essentiel. Car cela montre que le Prophète ﷺ reconnaissait clairement l'existence du chagrin profond, et qu'il donnait un remède concret.

9) Utiliser les causes sans tomber dans l'extrême

L'un des principes les plus importants dans l'approche islamique est l'équilibre.

Certaines personnes pensent que la dépression doit être soignée uniquement par la roqya. D'autres pensent qu'il faut uniquement des solutions psychologiques. En réalité, l'islam nous enseigne une voie complète : on soigne le cœur et on soigne le corps.

Le Prophète ﷺ a enseigné que pour chaque maladie, Allah a créé un remède. Cela inclut les remèdes spirituels et les remèdes médicaux.

Ainsi, une personne dépressive peut lire le Coran, faire ses invocations, prier, se rapprocher d'Allah, tout en prenant un traitement médical si nécessaire, ou en consultant un professionnel.

Et surtout, il ne faut jamais demander à une personne d'arrêter un traitement brutalement. Cela peut être dangereux.

Conclusion (de la partie) :

Le Coran et la Sounna offrent une approche très complète face à la dépression. Ils ne nient pas la souffrance. Ils ne culpabilisent pas la personne. Au contraire, ils lui donnent un cadre, un sens, et des moyens concrets.

Le Coran soigne le cœur, la prière stabilise l'âme, l'invocation libère la pression intérieure, la patience donne la force de tenir, la gratitude rallume une lumière, le soutien protège de l'isolement, et la médecine prophétique apporte des remèdes concrets.

Finalement, la dépression peut devenir une épreuve qui forge, purifie et rapproche d'Allah, à condition que la personne soit accompagnée, qu'elle utilise les causes, et qu'elle ne perde pas espoir dans la miséricorde d'Allah.

IX. Témoignage personnel

Je voudrais partager une expérience personnelle qui illustre une période où j'ai vécu une angoisse forte, qui a fini par se transformer en tristesse profonde et en abattement.

Lorsque je suis arrivé sur la ville de Marseille, j'ai quitté la maison familiale pour emménager avec mon épouse. Tout était nouveau : le quartier, le mode de vie, les codes, la mentalité. Je n'avais aucun ami, aucun repère, et je devais reconstruire une stabilité à partir de zéro.

Sur le plan sentimental et religieux, je me sentais mieux. J'avais l'impression d'être plus stable intérieurement, plus proche d'Allah, et plus apaisé. Mais sur le plan professionnel, c'était le chaos. J'avais quitté un CDD en tant qu'éducateur sportif pour me lancer en tant que coach sportif indépendant à Marseille. Et très vite, je me suis retrouvé sous pression.

Je devais payer un loyer de 700 euros par mois à mon head trainer, alors que j'avais énormément de difficultés à trouver des clients. Je vivais avec une peur constante. J'étais angoissé de ne pas pouvoir payer ce loyer, et celui de mon appartement, angoissé à l'idée de laisser ma femme prendre en charge une partie des frais du foyer. Petit à petit, je me suis senti impuissant, faible, et je ne trouvais plus ma place.

J'avais l'impression de profiter de ma femme à cause de ma situation financière. Et en même temps, j'avais l'impression de ne pas être à la hauteur dans mon métier de coach. Je me sentais sous pression parce que, l'homme doit s'occuper de son foyer. Et malgré mes efforts, j'en étais presque incapable. J'ai développé une forme de honte.

Malgré cela, je me suis accroché. Je continuais à me tourner vers Allah sans désespérer. Je me suis formé à la vente, j'ai essayé d'améliorer mon état d'esprit, mais au final la situation était trop instable et j'ai fini par intégrer une Maison Pour Tous dans les quartiers difficiles de Marseille, où je suis devenu animateur jeunes.

C'était loin de mon expérience dans le sport, mais il me fallait une stabilité financière, alors j'ai accepté un nouveau CDD. Je me souviens que le soir, après la mosquée, je marchais dans les rues et je me demandais pourquoi Allah me faisait vivre ça. J'avais tout quitté pour me rapprocher de Lui, et pourtant je me sentais inutile je savais que c'était une épreuve et que nous sommes sur terre pour être éprouver... Mais lorsque l'épreuve dure depuis plusieurs mois et qu'on a une famille à charge alors la pression devient encore plus forte. J'avais l'impression que mon expérience ne servait à rien, que mes diplômes ne m'ouvraient aucune porte. Les emplois n'étaient pas ce que je pensais être, et je ne m'épanouissais pas.

J'étais triste, abattu. J'avais honte de ne pas pouvoir m'occuper de mon foyer comme je l'avais imaginé avant le mariage. Je me disais : "Allah me détruit pour me reconstruire, je le sais, mais ça fait tellement mal." Et parfois, à l'abri des regards, je fondais en larmes. Tout en gardant malgré tout l'espoir qu'il y aurait une issue favorable.

Puis j'ai dû quitter ce poste d'animateur jeunesse, car le décalage entre mon histoire dans le milieu sportif et les attentes du poste était trop important. Il n'y avait pas non plus de valorisation de mon expérience, et je n'étais pas rémunéré à ma juste valeur. Cependant,

cette expérience m'a permis de me faire des contacts. Et par la grâce d'Allah, je me suis remis à mon compte et j'ai réussi à travailler avec eux pendant un certain temps.

Ce n'était toujours pas parfait financièrement, mais je sentais que je me rapprochais de quelque chose de plus cohérent, quelque chose qui était davantage en adéquation avec moi.

Avec du recul, je comprends que cette période m'a appris plusieurs choses. Elle m'a appris la patience, la dépendance à Allah, et surtout le fait que la vie n'est pas une ligne droite. Parfois, Allah fait passer une personne par une phase où elle se sent humiliée ou abaissée, non pas pour la détruire, mais pour la purifier, l'éduquer, et la reconstruire sur des bases plus solides. Et même si cette période a été très douloureuse, elle a été une étape essentielle dans mon cheminement.

X. Conclusion générale

La dépression est une réalité complexe, qui ne se résume pas à une simple baisse de moral. Elle touche à la fois le corps, l'esprit, les émotions, mais aussi la vie sociale et professionnelle. À travers l'étude des symptômes, des causes et des conséquences, nous comprenons qu'elle peut s'installer progressivement, parfois de manière silencieuse, et qu'elle peut affecter profondément la qualité de vie d'une personne. Elle peut également entraîner un cercle vicieux où la souffrance mentale aggrave la souffrance physique, et inversement.

Cependant, l'islam apporte une vision équilibrée face à cette épreuve. D'un côté, il reconnaît la souffrance humaine, la tristesse et la fragilité, car même les prophètes ont connu des périodes de douleur et d'abattement. De l'autre, il donne des moyens concrets pour faire face, à travers la foi, la patience, la prière, l'invocation, le rappel d'Allah, et la confiance dans le destin. Les remèdes prophétiques ne se limitent pas à des pratiques spirituelles, mais offrent aussi un cadre de vie sain, une manière de penser et de se comporter qui protège le cœur et apaise l'âme.

Enfin, à travers mon témoignage personnel, j'ai compris que certaines périodes de vie peuvent sembler injustes, lourdes et incompréhensibles sur le moment. Mais avec le recul, elles prennent un sens. J'ai compris que même les moments difficiles peuvent être une forme d'éducation et de préparation, et que lorsqu'une personne garde l'intention sincère de se rapprocher d'Allah, aucun effort n'est perdu. Ainsi, la dépression, bien qu'elle soit une épreuve douloureuse, peut aussi devenir une étape de transformation, si elle est accompagnée de bonnes causes, de soutien, et surtout d'un retour sincère vers Allah.

Références :

Le Noble Coran Référence principale

Recueils de hadiths (sources primaires)

Al-Bukhârî, Muhammad ibn Ismâ'îl (256H). Al-Jâmi' as-Sahîh (Sahih al-Bukhârî).

Muslim ibn al-Hajjâj (261H). Al-Musnad as-Sahîh (Sahih Muslim).

Abû Dâwûd, Sulaymân ibn al-Ash'ath (275H). Sunan Abî Dâwûd.

At-Tirmidhî, Muhammad ibn 'Îsâ (279H). Al-Jâmi' (Jâmi' at-Tirmidhî).

An-Nasâ'î, Ahmad ibn Shu'ayb (303H). As-Sunan al-Kubrâ / As-Sunan as-Sughrâ.

Ibn Mâjah, Muhammad ibn Yazîd (273H). Sunan Ibn Mâjah.

Ahmad ibn Hanbal (241H). Al-Musnad (Musnad Ahmad).

Livres de du'â et de rappel (très utiles pour stress / dépression)

An-Nawawî, Yahyâ ibn Sharaf (676H). Riyâd as-Sâlihîn.

An-Nawawî, Yahyâ ibn Sharaf (676H). Al-Adhkâr.

Tafsîr (exégèse du Coran) : sources majeures

Ibn Kathîr, Ismâ'îl ibn 'Umar (774H). Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm.

Al-Qurtubî, Muhammad ibn Ahmad (671H). Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân.

At-Tabarî, Muhammad ibn Jarîr (310H). Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ây al-Qur'ân.

Auteurs centraux (Sunnah, maladies du cœur, remèdes spirituels)

Ibn al-Qayyim (référence principale du mémoire)

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Muhammad ibn Abî Bakr (751H).
Zâd al-Ma'âd fî Hadyi Khayr al-'Ibâd.

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (751H).
Ad-Dâ' wa ad-Dawâ' (aussi connu sous : Al-Jawâb al-Kâfî liman sa'ala 'an ad-Dawâ' ash-Shâfî).

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (751H).
Al-Wâbil as-Sayyib min al-Kalim at-Tayyib.

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (751H).
Madarij as-Sâlikîn bayna Manâzil Iyyâka Na'budu wa Iyyâka Nasta'in.

Ibn Taymiyya (tawakkul, épreuves, purification du cœur)

Ibn Taymiyya, Ahmad ibn 'Abd al-Halîm (728H).
Majmû' al-Fatâwâ.

Ibn Taymiyya (728H).
Al-'Ubudiyyah.

Ibn Taymiyya (728H).
Al-Istiqâmah.